

Neumonía ambulatoria y neumonía atípica

A quién se puede tratar en casa · Los agentes atípicos y sus pistas clínicas · Esquemas orales, duración y control

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección IV (Infectología ambulatoria)

Glosario de siglas: NAC: neumonía adquirida en la comunidad · PSI: *Pneumonia Severity Index* · CRB-65: versión del CURB-65 sin urea · TDR: test de detección rápida · PCR: proteína C reactiva · EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica · SIADH: síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética · CK: creatinquinasa · MINSAL: Ministerio de Salud de Chile.

Alcance y fuentes. Basado en la guía ATS/IDSA de neumonía adquirida en la comunidad (2019), el consenso chileno de manejo de la NAC del adulto (Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias y SOCHINF; **verificar versión vigente**) y los ensayos de duración corta. Este documento se centra en el manejo **ambulatorio**; para la evaluación de gravedad completa, la NAC hospitalizada y grave, ver Neumonía adquirida en la comunidad.

Índice

1. La decisión central: dónde tratar
2. Herramientas de evaluación de gravedad en el ambulatorio
3. Factores que inclinan a hospitalizar más allá del puntaje
4. Diagnóstico en el ambulatorio
5. El concepto de "neumonía atípica" y sus límites
6. Los agentes atípicos, uno por uno
7. Tratamiento ambulatorio
8. Duración y control
9. Falta de respuesta en el ambulatorio
10. Prevención
11. Errores frecuentes
12. Perlas de alto rendimiento
13. Bibliografía esencial

1. La decisión central: dónde tratar

En la NAC ambulatoria, **la decisión de mayor impacto no es qué antibiótico usar, sino dónde tratar al paciente**. Hospitalizar innecesariamente expone a complicaciones y costos; dar de alta a un paciente que se descompensará es el error más grave.

La mortalidad de la NAC tratada ambulatoriamente es **inferior al 1 %**, mientras que la del paciente que requiere hospitalización asciende al 5-15 %.

2. Herramientas de evaluación de gravedad en el ambulatorio

CRB-65 (versión del CURB-65 sin urea, útil cuando no hay laboratorio disponible):

Letra	Criterio
C	Confusión
R	Frecuencia respiratoria $\geq 30/\text{min}$
B	Presión arterial sistólica < 90 o diastólica ≤ 60 mmHg
65	Edad ≥ 65 años

Puntaje	Conducta
0	Manejo ambulatorio

Puntaje	Conducta
1-2	Considerar hospitalización o manejo supervisado
>= 3	Hospitalizar

PSI (Pneumonia Severity Index)**: más complejo, pero **es el que mejor identifica a los pacientes de bajo riesgo** que pueden manejarse en casa, y **las guías ATS/IDSA 2019 lo prefieren** sobre el CURB-65 para esta decisión. Clasifica en cinco clases: **las clases I y II se manejan ambulatoriamente**, la III puede requerir observación breve, y las IV y V se hospitalizan.

La **saturometría es obligatoria** en toda evaluación de una NAC ambulatoria: **una saturación < 92 % respirando aire ambiental es criterio de hospitalización**, independientemente del puntaje.

3. Factores que inclinan a hospitalizar más allá del puntaje

- **Hipoxemia** (saturación < 92 %). - **Incapacidad de tolerar la vía oral** o vómitos. - **Comorbilidad descompensada**: insuficiencia cardíaca, EPOC, diabetes, insuficiencia renal o hepática, neoplasia activa. - **Inmunosupresión**. - **Derrame pleural significativo, compromiso multilobar o cavitación** en la radiografía. - **Sospecha de aspiración** con compromiso de la deglución. - **Falta de red de apoyo**, adherencia dudosa, imposibilidad de control en 48-72 horas, dificultades de acceso o de transporte. - **Fracaso de un tratamiento oral previo**. - **Embarazo**.

El juicio clínico y las condiciones sociales pesan tanto como el puntaje: una regla de predicción mide riesgo de mortalidad, no capacidad de cuidarse en casa.

4. Diagnóstico en el ambulatorio

- **Radiografía de tórax**: necesaria para confirmar el diagnóstico. Puede ser falsamente negativa en las primeras horas o en la deshidratación.
- **Saturometría**: obligatoria.
- **Exámenes de laboratorio**: no son imprescindibles en el paciente de bajo riesgo sin comorbilidad. Se solicitan si hay dudas de gravedad o comorbilidad relevante.
- **Estudio microbiológico**: **NO se recomienda de rutina** en la NAC ambulatoria (ni hemocultivos, ni cultivo de expectoración, ni antígenos urinarios). El rendimiento es bajo y el resultado rara vez cambia la conducta.
- **Se estudia** cuando hay: sospecha de agente inusual, brote, viaje reciente, exposición epidemiológica particular, fracaso del tratamiento, o inmunosupresión.
- **Panel viral respiratorio**: útil en temporada, sobre todo para **influenza** (que cambia la conducta, porque se agrega antiviral) y para decisiones de aislamiento.
- **Considerar tuberculosis** ante curso subagudo, baja de peso, sudoración nocturna, compromiso de lóbulos superiores o cavitación: **pedir baciloscopías y estudio molecular**.
- **Procalcitonina**: **no debe usarse para decidir el inicio** del antibiótico (ensayo ProACT).

5. El concepto de "neumonía atípica" y sus límites

El término nació para describir cuadros que no respondían a penicilina y cuya presentación difería de la neumonía neumocócica clásica. Hoy conviene usarlo con cuidado:

Perspectiva	Contenido
Lo que sigue siendo válido	Los agentes "atípicos" — <i>Mycoplasma</i> , <i>Chlamydia</i> , <i>Legionella</i> — no tienen pared celular convencional o son intracelulares , y por tanto no responden a betalactámicos . Esto tiene consecuencia terapéutica directa
Lo que ya no se sostiene	La presentación clínica NO permite distinguir de forma fiable una neumonía atípica de una neumocócica. Múltiples estudios han mostrado que ni la clínica, ni el laboratorio, ni la radiografía discriminan con precisión suficiente para decidir el tratamiento

La **consecuencia práctica** es que el esquema empírico se elige **cubriendo o no atípicos según el perfil del paciente y la gravedad**, no según la "impresión de atipicidad".

Elementos que sí aumentan la sospecha de agente atípico (sin ser diagnósticos): edad joven, inicio subagudo, **predominio de síntomas extrapulmonares** (cefalea, mialgias, odinofagia, diarrea), tos seca prolongada, disociación entre un examen pulmonar pobre y una radiografía llamativa, brote familiar o institucional.

6. Los agentes atípicos, uno por uno

Agente	Epidemiología	Claves clínicas	Diagnóstico	Tratamiento
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	Adultos jóvenes; brotes en comunidades cerradas (colegios, cuarteles, familias); ciclos epidémicos cada 3-7 años	Tos seca persistente, odinofagia, cefalea, curso subagudo. Manifestaciones extrapulmonares: eritema multiforme, anemia hemolítica por crioaglutininas , miringitis bulosa, artralgias, encefalitis, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Stevens-Johnson	PCR de muestra respiratoria (de elección); serología con IgM (baja especificidad) o títulos pareados	Macrólido (azitromicina), doxiciclina o quinolona respiratoria
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	Todas las edades; transmisión persona a persona	Curso insidioso, odinofagia y disfonía previas a la tos; puede asociarse a exacerbación de asma	PCR; serología de interpretación difícil	Macrólido, doxiciclina o quinolona
<i>Legionella pneumophila</i>	Agua aerosolizada : sistemas de aire acondicionado, torres de enfriamiento, duchas, jacuzzis, hoteles, cruceros, obras. Brotes	Neumonía frecuentemente grave . Fiebre alta, diarrea, confusión, hiponatremia , elevación de transaminasas y de CK, bradicardia relativa. Falta de respuesta a betalactámicos	Antígeno urinario (detecta sólo el serogrupo 1 , que causa la mayoría de los casos), PCR , cultivo en medio BCYE (hay que pedirlo explícitamente)	Quinolona respiratoria (levofloxacin) o azitromicina . No responde a betalactámicos . Es de notificación obligatoria
<i>Chlamydia psittaci</i> (psitacosis)	Contacto con aves : loros, pericos, palomas, aves de corral	Fiebre alta, cefalea intensa, tos seca, hepatoesplenomegalia	Serología, PCR	Doxiciclina
<i>Coxiella burnetii</i> (fiebre Q)	Contacto con ganado , productos de parto animal, lácteos no pasteurizados	Neumonía, hepatitis, fiebre prolongada; forma crónica con endocarditis	Serología (IgG antifase I y II)	Doxiciclina
Virus respiratorios	Estacional	Influenza, VRS, SARS-CoV-2, metapneumovirus, adenovirus	Panel molecular	Soporte; antiviral en influenza y COVID-19

Lo que más se pregunta de *Legionella* Neumonía grave con diarrea, confusión, hiponatremia y elevación de transaminasas o CK, que no responde a betalactámicos -> pensar en *Legionella*, pedir **antígeno urinario** y tratar con **quinolona respiratoria o azitromicina**. Recordar que el antígeno **sólo detecta el serogrupo 1** y que la enfermedad es de **notificación obligatoria**, porque puede haber una fuente ambiental común.

7. Tratamiento ambulatorio

Esquemas según la guía ATS/IDSA 2019, ajustados a la resistencia local:

Perfil del paciente	Esquema
Sano, sin comorbilidad ni antibiótico reciente	Amoxicilina 1 g VO cada 8 h · o doxiciclina 100 mg cada 12 h · o macrólido (azitromicina 500 mg el día 1 y 250 mg los días 2-5, o claritromicina) sólo si la resistencia local de neumococo a macrólidos es < 25 %
Con comorbilidad (cardiopatía, enfermedad pulmonar, hepática o renal crónica, diabetes, alcoholismo, neoplasia, asplenia) o antibiótico en los últimos 3 meses	Terapia combinada: amoxicilina-ácido clavulánico (o cefalosporina como cefuroxime o cefpodoxima) más macrólido o doxiciclina · o quinolona respiratoria en monoterapia (levofloxacin 750 mg/día o moxifloxacin 400 mg/día)

Consideraciones sobre la elección:

- La **monoterapia con macrólido** está muy limitada por la resistencia de neumococo, que en muchos lugares supera ampliamente el 25 %. **Verificar el antibiograma acumulado local**.
- Las **quinolonas respiratorias** son eficaces y cómodas, pero su uso indiscriminado tiene costos: selección de resistencia, riesgo de **enmascarar una tuberculosis** (son activas frente a *M. tuberculosis* y pueden retrasar su diagnóstico), y las advertencias regulatorias sobre tendinopatía, aneurisma aórtico, neuropatía y neurotoxicidad. **Se reservan** para pacientes con comorbilidad,

alergia a betalactámicos o fracaso previo.

- **La amoxicilina en dosis altas (1 g cada 8 h)** sigue siendo excelente para el neumococo, que es el agente bacteriano más frecuente en todos los niveles de gravedad.
- **En sospecha de influenza**, agregar **oseltamivir**.

8. Duración y control

- **Duración mínima: 5 días**, siempre que el paciente esté **afebril por 48 horas** y **clínicamente estable** (frecuencia cardíaca < 100, frecuencia respiratoria < 24, presión sistólica $\geq$ 90, saturación $\geq$ 90 %, tolerancia oral, estado mental basal). El ensayo de **Uranga** (*JAMA Intern Med* 2016) validó esta estrategia.
- **Prolongar** sólo ante: agente específico que lo requiera (*S. aureus*, *P. aeruginosa*, *Legionella* en el inmunosuprimido), complicación (absceso, empiema), o falta de estabilización.
- **Control clínico a las 48-72 horas** — es parte del manejo ambulatorio, no un extra: permite detectar precozmente el fracaso y la necesidad de hospitalizar.
- **La radiografía de control no es necesaria para el alta ni para suspender el antibiótico**: la resolución radiológica tarda **4-8 semanas**, y más en el adulto mayor.
- **Radiografía de control a las 6-8 semanas** en pacientes con **factores de riesgo de neoplasia** (edad > 50 años, tabaquismo, síntomas persistentes), para descartar una lesión subyacente.
- **Anticipar el curso**: la tos y la fatiga pueden persistir semanas; explicarlo evita reconsultas y cambios innecesarios de antibiótico.

9. Falta de respuesta en el ambulatorio

Ausencia de mejoría a las 72 horas obliga a **reevaluar presencialmente** y considerar:

Categoría	Ejemplos
Agente no cubierto	<i>Legionella</i> (si no se cubrieron atípicos), <i>S. aureus</i> , <i>P. aeruginosa</i> , tuberculosis , hongos, virus
Agente resistente	Neumococo resistente a macrólidos
Complicación	Derrame paraneumónico o empiema , absceso, neumonía necrotizante
Diagnóstico incorrecto	Tromboembolismo pulmonar , insuficiencia cardíaca, neoplasia, neumonía organizada, neumonitis por hipersensibilidad, vasculitis, toxicidad por fármacos
Problema del huésped	Inmunosupresión no reconocida (pedir estudio de VIH), obstrucción bronquial, aspiración recurrente
Problema del tratamiento	Mala adherencia, dosis insuficiente, intolerancia digestiva

Conducta: repetir la imagen (considerar tomografía), **hospitalizar si hay deterioro**, ampliar el estudio microbiológico, y reconsiderar el diagnóstico antes de simplemente cambiar de antibiótico.

10. Prevención

- **Vacuna antineumocócica** y **vacuna anual contra influenza** en las poblaciones definidas por el **Programa Nacional de Inmunizaciones**; verificar el calendario vigente.
- **Vacunas contra COVID-19 y VRS** según las recomendaciones nacionales vigentes.
- **Cese del tabaquismo** — la intervención preventiva de mayor impacto individual.
- **Higiene bucal y control odontológico**; manejo de la disfagia en el paciente con riesgo de aspiración.
- **Control de comorbilidades**, en particular diabetes e insuficiencia cardíaca.

11. Errores frecuentes

- **No medir la saturación** en la evaluación ambulatoria. - **Decidir el alta sólo por el puntaje**, sin considerar comorbilidad, tolerancia oral y red de apoyo. - **Usar ciprofloxacino: no cubre neumococo** y no tiene lugar en la NAC. - **Usar macrólido en monoterapia** donde la resistencia local del neumococo es alta. - **Usar quinolona respiratoria como primera opción de rutina** en un paciente sano. - **Tratar 10-14 días** una neumonía que respondió bien: 5 días bastan. - **Pedir radiografía de control precoz** y prolongar el antibiótico porque "el infiltrado sigue". - **No citar a control a las 48-72 horas**. - **No pensar en tuberculosis** en un cuadro subagudo con compromiso apical, y **enmascararla con una quinolona**. - **No pedir antígeno urinario de *Legionella*** ante un cuadro compatible, y no notificar el caso. - **No solicitar radiografía de control a las 6-8 semanas** en un fumador mayor de 50 años.

12. Perlas de alto rendimiento

- **La decisión más importante es dónde tratar**; el PSI identifica mejor al paciente de bajo riesgo, y **la saturación < 92 % hospitaliza** por sí sola.
- **En la NAC ambulatoria no se recomienda estudio microbiológico de rutina.**
- **La clínica no distingue de forma fiable neumonía atípica de neumocócica**: el esquema se elige por el perfil del paciente, no por la "impresión".
- **Los atípicos no responden a betalactámicos.**
- ***Legionella*: neumonía grave con diarrea, confusión, hiponatremia y alza de transaminasas y CK.** Antígeno urinario (sólo serogrupo 1), quinolona o azitromicina, y **notificación obligatoria.**
- ***Mycoplasma*: adulto joven, brotes, eritema multiforme y anemia por crioaglutininas.**
- ***Psittaci* -> aves; *Coxiella* -> ganado.** Ambas se tratan con **doxiciclina.**
- **Paciente sano: amoxicilina 1 g cada 8 h. Con comorbilidad: betalactámico + macrólido, o quinolona respiratoria.**
- **Mínimo 5 días, afebril 48 horas y estable.**
- **La radiografía se normaliza mucho después que el paciente**; control a las 6-8 semanas sólo si hay riesgo de neoplasia.
- **Control clínico a las 48-72 horas es parte del tratamiento ambulatorio.**
- **No mejorar a las 72 horas obliga a repensar el diagnóstico**, no sólo a cambiar el antibiótico.

13. Bibliografía esencial

- Metlay JP, Waterer GW, Long AC, et al. Diagnosis and treatment of adults with community-acquired pneumonia: an official clinical practice guideline of the ATS and IDSA. *Am J Respir Crit Care Med*. 2019;200:e45-e67.
- Uranga A, España PP, Bilbao A, et al. Duration of antibiotic treatment in community-acquired pneumonia: a multicenter randomized clinical trial. *JAMA Intern Med*. 2016;176:1257-65.
- Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, et al. A prediction rule to identify low-risk patients with community-acquired pneumonia (PSI). *N Engl J Med*. 1997;336:243-50.
- Lim WS, van der Eerden MM, Laing R, et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital (CURB-65). *Thorax*. 2003;58:377-82.
- Huang DT, Yealy DM, Filbin MR, et al. Procalcitonin-guided use of antibiotics for lower respiratory tract infection (ProACT). *N Engl J Med*. 2018;379:236-49.
- Cunha BA. The atypical pneumonias: clinical diagnosis and importance. *Clin Microbiol Infect*. 2006;12(Suppl 3):12-24.
- Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias y Sociedad Chilena de Infectología. Consenso de manejo de la neumonía adquirida en la comunidad del adulto. Verificar la versión vigente.